

# 张建来 mPDAC MDT 病史汇报 2026-07-15

## 张建来 晚期胰腺导管腺癌 MDT 病史汇报

**汇报日期:** 2026-07-15 **汇报目的:** 提交多学科会诊 (MDT), 讨论一线 AG 化疗中亚急性胆管炎反弹处置、胆道支架策略、二线/联合治疗 (含临床试验) 方向

### 一、患者基本信息

| 项目    | 内容                                                |
|-------|---------------------------------------------------|
| 姓名    | 张建来                                               |
| 性别    | 男                                                 |
| 出生日期  | 1958-05-04 (68 岁)                                 |
| 身份证号  | 340504195805040039                                |
| 民族    | 汉族                                                |
| 籍贯    | 安徽省 (久居北京)                                        |
| 婚姻    | 离婚, 育 1 子 (体健)                                    |
| 职业    | 退休 (原北京瑞尔非金属材料有限公司)                               |
| 永久地址  | 北京市海淀区小营西路橡树湾五期万象府 8 号楼 2 单元 401                  |
| 紧急联系人 | 张成毅 (子), 18600058581                              |
| 当前住院  | 北京中关村医院 肿瘤病区 (住院号 106034, 床号 05-09, 2026-06-23 起) |

### 二、主诊断与分期

**主诊断:** 胰腺中低分化导管腺癌 (PDAC), 胰头钩突占位, IV 期 (cT3N1M1, 肝多发转移)

**病理确诊:** 2026-04-07 EUS-FNA 穿刺活检 (北医三院) **首发症状时间:** 2026 年 3 月中下旬皮肤巩膜黄染  
**分期依据:** 2026-06-14 中国医学科学院肿瘤医院上腹 MR 动态增强+DWI 明确肝多发转移瘤 **可切除性:** 不可手术 (SMV 受压+可疑 SMA 侵犯+肝多发转移)

### 三、既往史与合并症

#### 3.1 既往合并症（2026-04-03 北医三院入院志记载）

| 慢病       | 病史                  | 长期用药                                                                         |
|----------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 高血压病 3 级 | 20 余年（最高 180 mmHg）  | 缬沙坦 80 mg QD + 氨氯地平 5 mg QD                                                  |
| 高血压性脑出血  | 8 年（2018 年），保守治疗后好转 | —                                                                            |
| 陈旧性脑梗死   | 3 年（2023 年），遗留双下肢无力 | —                                                                            |
| 帕金森综合征   | 数年                  | 雷沙吉兰 1 mg QD + 金刚烷胺 0.1 g BID + 甲钴胺 0.5 mg QD + 多巴丝肼 0.125 g-0.5 g-0.5 g TID |
| 高脂血症     | 数年                  | 阿托伐他汀 20 mg QN                                                               |
| 脑卒中二级预防  | —                   | 西洛他唑 50 mg BID（抗血小板）                                                         |

#### 3.2 既往手术史

- **本次胰腺癌之前无任何大手术史**（2026-06-28 家属复核）
- 本次相关手术：
  - 2026-04-07 EUS-FNA 胰腺穿刺活检（北医三院）
  - 2026-04-10 ERCP + DSA 胆道**塑料**支架置入术（北医三院，张铃福医生）
  - 2026-06-22 内镜下经鼻三腔营养管置入术（北医三院普外急诊，姚炜/张耀朋，因胃潴留+十二指肠恶性狭窄）
  - **2026-07-02 十二指肠 SEMS 金属自膨胀支架置入术**（北医三院，姚炜团队；同期撤除三腔营养管，恢复口服）

#### 3.3 过敏史

**无药物、食物、造影剂过敏史**（2026-06-28 家属复核）

#### 3.4 个人史

- 生于安徽，久居北京
- **不吸烟、不饮酒**（入院志与家属双重确认）
- 无疫区/疫水、无化学放射性接触史、无吸毒史

#### 3.5 家族史

**否认家族性遗传病史与肿瘤家族史。**综合"不吸烟+不饮酒+无家族肿瘤史"及基因检测（KRAS G12D + CDKN2A + Smad4 缺失）→ 提示**散发性体细胞驱动突变型 PDAC**，非遗传性。

## 四、诊疗时间线（关键节点）

| 日期                 | 医院                     | 关键事件                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2026-02-末 / 03-初   | —                      | 出现皮肤巩膜黄染（首发症状）                                                                                                                                                                                                  |
| 2026-03-30         | 北京协和急诊                 | 基线全套：CA19-9 <b>2203</b> 、TBIL 162.3、ALT 214、CRP 23.76、AMY 184；胸部 CT 示胆总管下段团块                                                                                                                                    |
| 2026-04-01         | 北京协和（国际医疗肝胆外科）         | 首诊：胰腺恶性肿瘤 + 梗阻性黄疸                                                                                                                                                                                               |
| 2026-04-02         | 北京协和（特需基本外科）           | 制定"新辅助化疗 + 胆道引流"方案                                                                                                                                                                                              |
| 2026-04-03         | 北医三院普外二病房（住院号 5047176） | 入院；MRCP：胰头肿块 45 mm，双管征                                                                                                                                                                                          |
| 2026-04-04         | 北医三院                   | 腹盆腔 CT 增强：胰头 45 mm，与门静脉关系密切；消化系统彩超：胰头钩突 <b>7.1×4.1×3.6 cm</b> 、SMV 受压、CBD 2.3 cm 极度扩张、肝囊肿 1.5 cm、胆囊息肉 0.3 cm、 <b>肝脏未见转移瘤</b> ；双下肢静脉： <b>无血栓（VTE 基线）</b> ；颈动脉：双侧粥样斑块（0-49% 轻度狭窄）                                 |
| 2026-04-07         | 北医三院                   | EUS-FNA 穿刺活检 → 病理： <b>胰腺中低分化腺癌</b> ；超声造影示典型 PDAC 乏血供表现                                                                                                                                                          |
| 2026-04-10         | 北医三院                   | <b>ERCP + DSA 胆道塑料支架置入术</b> （张铃福医生）                                                                                                                                                                             |
| 2026-04-14         | 北医三院                   | 出院；出院带药：耐信 20 mg BID + 易善复 456 mg TID + 天晴甘平 150 mg TID + 迪先 10 ml BID                                                                                                                                          |
| 2026-04-16 / 04-22 | 北医三院                   | 病理免疫组化补充：MMR pMMR、HER2 1+、PD-L1 CPS<1、Smad4 缺失                                                                                                                                                                  |
| 2026-04-27         | 北医三院                   | NGS 报告： <b>KRAS G12D、TP53 V274D、CDKN2A 缺失、ARID1A、MTAP 缺失、Claudin18.2 3+ 60%</b>                                                                                                                                 |
| 2026-05-09         | 中国医学科学院肿瘤医院            | <b>化疗前真正基线 CT 增强（胸+全腹+盆腔+薄层）</b> ：胰头 4.2×3.8 cm，侵犯十二指肠降+水平段、SMV、可疑 SMA； <b>肝多发转移瘤可能（最大 1.2×1.1 cm）</b> ；淋巴结 0.9 cm；腹+盆腔少量积液+腹膜稍厚；双肺结节 0.8×0.5 cm；双肾囊肿 → <b>实际确诊即 IV 期 mPDAC</b> （05-12 出院时报告为 T3N0M0 II 期系初步低估） |
| 2026-05-11         | 肿瘤医院                   | <b>C1D1 AG 化疗</b> ：白蛋白紫杉醇 190 mg + 吉西他滨 1.6 g                                                                                                                                                                   |
| 2026-05-13         | 清华长庚                   | 苏日嘎教授（肝胆肿瘤科）咨询意见                                                                                                                                                                                                |
| 2026-05-25         | 肿瘤医院                   | <b>C2D1（方案改为 14 天周期）</b>                                                                                                                                                                                        |

| 日期                | 医院        | 关键事件                                                                                                                                                                  |
|-------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2026-06-08        | 肿瘤医院      | <b>C3D1</b>                                                                                                                                                           |
| 2026-06-13        | 肿瘤医院      | CT 增强疗效评估：胰头 4.2×3.8 cm 稳定；肝结节部分较前缩小；淋巴结 0.9→0.7 cm → <b>AG 有效</b>                                                                                                    |
| 2026-06-14        | 肿瘤医院      | 上腹 MR 动态增强+DWI： <b>明确肝多发转移瘤（1.2×1.0 cm）→ 分期 II 上调 IV（mPDAC）</b>                                                                                                       |
| 2026-06-21        | 急诊        | ☑ 反酸呕吐 24 h + 发热 39.2 °C + WBC 13.15/NEUT% 91.1%/CRP 69 + ALT 632/AST 520/ALP 540/GGT 608/TBIL 39.7 → <b>急性胆管炎 Grade II（胆道塑料支架相关）+ 恶性十二指肠梗阻</b>                       |
| 2026-06-22        | 北医三院      | 美罗培南 15 h 有效（PCT 2.91→1.88，AST 520→238）； <b>内镜下经鼻三腔营养管置入</b> （诊断：十二指肠降部恶性狭窄，建议必要时行 SEMS 或 EUS-GE）                                                                     |
| 2026-06-23        | 中关村医院肿瘤病区 | <b>转入住院（住院号 106034）</b> ；启动双轨营养 TPF 60 ml/h 鼻饲 + PN 约 650 kcal/d；抗生素降阶梯为头孢他啶+美洛西林+左奥硝唑三联；保肝（谷胱甘肽+硫普罗宁）                                                                |
| 2026-06-25        | 中关村       | 甲状腺自身抗体：TGAb 312 ↑ + TPOAb 72.2 ↑ → <b>桥本氏甲状腺炎</b> （新发现）；PCT 0.767；IL-6 23；呼吸道病原体 5 项 IgM 全阴                                                                          |
| 2026-07-01        | 北医三院      | 姚炜主任门诊 → 决定 <b>十二指肠 SEMS 置入术</b> （未选 EUS-GE）                                                                                                                          |
| 2026-07-02        | 北医三院胃镜室   | <b>十二指肠 SEMS 置入术</b> （BOSTON 6502 WallFlex 27/22×9 + Jagwire 导丝，医保 23,199 元）；同日上午北大肿瘤医院周军主任二线咨询门诊                                                                     |
| 2026-07-03        | 中关村       | 血液学全面恢复：WBC 5.42/NEUT 3.79/PLT 272/HGB 90 ↑； <b>PCT 0.135 ☑ 感染最低点</b> ；IL-6 11.63；肝功能爆炸性恢复： <b>ALT 25.5 (-96%)、AST 23.4 (-96%)、TBIL 7.8 (-80%) 全正常</b> ；仅 GGT 227.7 ↑ |
| <b>2026-07-12</b> | 中关村       | ☑ <b>全套化验三系反弹</b> （详见"当前问题"）                                                                                                                                          |

五、当前主要问题（2026-07-15，MDT 讨论核心）

☑ 5.1 亚急性胆管炎再激活 / 胆汁淤积型肝损伤反弹

7/12 化验（中关村，采样 09:30，7/13 报告）三系同步反弹：

① 感染指标反弹

| 指标   | 6/21 峰值 | 7/3 最低 | 7/12    | 参考     | 判断         |
|------|---------|--------|---------|--------|------------|
| PCT  | 2.91    | 0.135  | 0.522 ↑ | <0.046 | +286%（4 倍） |
| IL-6 | —       | 11.63  | 16.97 ↑ | <7     | +46%       |

② 肝功能（胆汁淤积型模式）

| 指标   | 7/3                                       | 7/12                                      | 参考   | 变化                |
|------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|------|-------------------|
| ALT  | 25.5 <input checked="" type="checkbox"/>  | 74.4 <input checked="" type="checkbox"/>  | 0-40 | +192% (1.86×)     |
| AST  | 23.4 <input checked="" type="checkbox"/>  | 30.2 <input checked="" type="checkbox"/>  | 0-40 | 正常                |
| GGT  | 227.7 <input checked="" type="checkbox"/> | 262.1 <input checked="" type="checkbox"/> | 0-50 | 5.24×             |
| ALP  | —                                         | —                                         | —    | 待查                |
| TBIL | 7.8 <input checked="" type="checkbox"/>   | 7.3 <input checked="" type="checkbox"/>   | 0-20 | 仍正常 (关键! 支架未完全堵塞) |
| DBIL | —                                         | 4.5 <input checked="" type="checkbox"/>   | 0-7  | 正常                |

③ 血液学 (感染消耗性)

| 指标       | 7/3                                      | 7/12                                     | 参考        | 判断            |
|----------|------------------------------------------|------------------------------------------|-----------|---------------|
| PLT      | 272                                      | 111 <input checked="" type="checkbox"/>  | 125-350   | -59% 消耗性血小板减少 |
| LYM#     | 1.06 <input checked="" type="checkbox"/> | 0.84 <input checked="" type="checkbox"/> | 1.10-3.20 | -21% 感染+化疗后叠加 |
| WBC/NEUT | 5.42/3.79                                | 待查                                       | —         | —             |

④ 代谢/营养 (恶病质早期)

| 指标  | 7/12                                      | 参考      | 判断                                                         |
|-----|-------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------|
| ALB | 32.8 <input checked="" type="checkbox"/>  | 35-55   | 低白蛋白 (营养不良+慢性炎症消耗)                                         |
| Cr  | 46 <input checked="" type="checkbox"/>    | 59-104  | 肌肉量减少 (cachexia 早期), 非肾功能问题                                |
| Na  | 133.6 <input checked="" type="checkbox"/> | 135-145 | 轻度低钠 (感染应激/PN 配比/摄入减少)                                     |
| AMY | 21.7 <input checked="" type="checkbox"/>  | 15-115  | 完全正常 → 排除 SEMS 术后急性胰腺炎 <input checked="" type="checkbox"/> |

临床判断 (证据链完整):

- 无发热、无腹痛、TBIL 正常 → 未达急性化脓性胆管炎, 处于**亚急性感染激活期**
- ALT/GGT/PCT/IL-6 同步反弹 → 病因同源
- 鉴别诊断三选一:**
  - 胆道塑料支架 3 个月堵塞 / 生物膜 (40%) —— 4/10 置入至今 3 个月余, 已入通畅期末期
  - 舒普深 + PN 药物性胆汁淤积 20 天暴露 (30%)
  - 两者叠加 (20%)

⚠️ **家属临床直觉:** 7/12 早间家人即提出"应早换金属胆道支架, 为何 SEMS 手术未同期置换?"—— 化验后 3 条独立证据链印证此判断。

5.2 十二指肠 SEMS 术后 (2026-07-02, D13)

- 恢复良好:** 已停鼻饲/PN, 营养全改口服; 无腹痛、无出血、无支架移位
- AMY 21.7 正常** → 排除胰腺刺激
- 需影像复查 (腹部 CT 或超声) 确认支架位置和胆道情况

5.3 化疗方案与耐药风险

- **AG 方案 C3 完成，一线响应良好**（6/13 CT：肝结节缩小、淋巴结 0.9→0.7 cm）
- 因 6/21 胆管炎急诊后中断化疗至今（3 周多），需评估是否继续 C4 及节奏调整
- **AG 中位 PFS 5.5-6 个月**（MPACT 研究），爸爸 5/11 起，7/15 已 2 个月余，需警惕耐药窗口

5.4 桥本氏甲状腺炎（新发现，2026-06-25）

- TGAb 312↑（2.7×）+ TPOAb 72.2↑（2.1×）；TRAb 正常
- 甲功五项待查
- 若拟入组免疫治疗试验（如恒瑞 HRS-4642 + Adebrelimab PD-L1），需先评估甲功基线

5.5 高凝状态与抗血小板/抗凝策略

- 6/24 D-Dimer 1.091↑↑；7/3 已回落至 0.468（-57%），无新发 DVT
- 4/4 双下肢基线无血栓
- 当前抗血小板：**西洛他唑 50 mg BID**（脑卒中二级预防继续）
- △ 7/12 PLT 111（消耗性减少）+ 西洛他唑 → **出血风险 vs 血栓预防**需 MDT 判断是否暂停或减量

六、关键影像学总结

| 检查                    | 日期                | 医院          | 关键发现                                                                                               |
|-----------------------|-------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 胸部 CT 平扫              | 2026-03-30        | 协和急诊        | 胆总管下段团块，双肺微小结节                                                                                     |
| MRCP                  | 2026-04-03        | 北医三院        | 胰头肿块 45 mm，双管征                                                                                     |
| 腹盆腔 CT 增强             | 2026-04-04        | 北医三院        | 胰头 45 mm，与门静脉关系密切                                                                                  |
| 消化系统彩超                | 2026-04-04        | 北医三院        | 胰头钩突 <b>7.1×4.1×3.6 cm</b> + SMV 受压 + CBD 2.3 cm 扩张 + <b>肝脏未见转移</b>                                |
| 超声造影（穿刺同期）            | 2026-04-07        | 北医三院        | 典型 PDAC 乏血供廓清早于胰腺组织                                                                                |
| <b>化疗前基线 CT 增强+薄层</b> | <b>2026-05-09</b> | <b>肿瘤医院</b> | 胰头 4.2×3.8 cm；侵犯十二指肠降+水平段 + SMV + 可疑 SMA； <b>肝多发转移瘤可能（1.2×1.1 cm）</b> ；淋巴结 0.9 cm；腹+盆腔积液；双肺结节；双肾囊肿 |
| <b>AG 疗效评估 CT 增强</b>  | <b>2026-06-13</b> | <b>肿瘤医院</b> | 胰头 4.2×3.8 cm 稳定；肝结节部分较前缩小；淋巴结 0.9→0.7 cm； <b>AG 有效</b>                                            |
| <b>上腹 MR 动态增强+DWI</b> | <b>2026-06-14</b> | <b>肿瘤医院</b> | 胰头 4.9×3.8 cm；肝多发 DWI 高信号结节 1.2×1.0 cm → <b>明确诊断"肝多发转移瘤"（分期升至 IV）</b>                              |

七、分子病理与基因检测（NGS 2026-04-27）

| 检测           | 结果                         | 临床意义                                                             |
|--------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------|
| KRAS         | G12D (c.35G>A, VAF 26.94%) | 驱动突变；G12D 特异性抑制剂在研（HRS-4642 / Zoldonrasib / GFH375 / INCB161734） |
| TP53         | V274D (c.821T>A, 37.12%)   | 抑癌基因失活；WEE1 抑制剂潜在靶点                                              |
| CDKN2A       | 拷贝数缺失（CN=1.16）             | 细胞周期失调                                                           |
| ARID1A       | D2178Gfs*47 (24.19%)       | 功能丧失                                                             |
| MTAP         | 杂合缺失（9p21.3）               | MAT2A 抑制剂靶点（在研）                                                  |
| RNF43        | A46S                       | Wnt 通路，意义不明                                                      |
| BIRC3        | BIRC3-METTL25B 融合（15.43%）  | 意义不明                                                             |
| MSI          | MSS                        | 免疫单药无效                                                           |
| TMB          | 4.1 突变/Mb（低）               | 免疫单药无效                                                           |
| PD-L1        | 阴性（CPS<1, SP263）           | 免疫单药无效                                                           |
| Smad4/DPC4   | 表达缺失                       | 预后不良，倾向远处转移；提示吉西他滨方案更适合                                          |
| HER2         | 1+（低表达）                    | 传统 HER2 靶向药不适；T-DXd 潜在二线备选                                       |
| MMR          | pMMR（四项正常）                 | 与 MSS 一致                                                         |
| Claudin 18.2 | 阳性（60%，3+）                 | 符合 CLDN18.2 靶向治疗标准（Zolbetuximab、CLDN18.2 ADC、CT041 CAR-T）        |
| BRCA1/2      | 无突变                        | PARP 抑制剂不适                                                       |

核心可干预靶点：

KRAS G12D（一级）+ Claudin 18.2 3+ 60%（一级）+ TP53/CDKN2A/MTAP（研究级）



## 八、当前用药清单

### 8.1 慢病长期用药（需 MDT 核对本次住院期间是否维持）

| 药物        | 剂量              | 频次  | 用途                                |
|-----------|-----------------|-----|-----------------------------------|
| 缬沙坦（代文）   | 80 mg           | QD  | 高血压                               |
| 氨氯地平（络活喜） | 5 mg            | QD  | 高血压                               |
| 雷沙吉兰      | 1 mg            | QD  | 帕金森综合征                            |
| 金刚烷胺      | 0.1 g           | BID | 帕金森综合征                            |
| 甲钴胺       | 0.5 mg          | QD  | 帕金森综合征                            |
| 多巴丝肼（美多巴） | 0.125-0.5-0.5 g | TID | 帕金森综合征                            |
| 阿托伐他汀     | 20 mg           | QN  | 调脂                                |
| 西洛他唑      | 50 mg           | BID | 脑卒中二级预防（抗血小板）— △ 7/12 PLT 111，需评估 |

### 8.2 出院/化疗相关用药

| 药物           | 剂量     | 频次            | 用途            |
|--------------|--------|---------------|---------------|
| 艾司奥美拉唑镁（耐信）  | 20 mg  | BID           | PPI 抑酸        |
| 多烯磷脂酰胆碱（易善复） | 456 mg | TID           | 保肝            |
| 甘草酸二铵（天晴甘平）  | 150 mg | TID           | 保肝抗炎          |
| 硫糖铝（迪先）      | 10 ml  | BID           | 黏膜保护          |
| 白蛋白结合型紫杉醇    | 190 mg | ivgtt d1 q14d | AG 化疗（末次 6/8） |
| 吉西他滨         | 1.6 g  | ivgtt d1 q14d | AG 化疗（末次 6/8） |
| 昂丹司琼         | 8 mg   | 按需 q8-12h     | 化疗止呕          |

### 8.3 本次住院期间（中关村，2026-06-23 起）

| 药物                      | 用途                     | 备注               |
|-------------------------|------------------------|------------------|
| 头孢他啶 + 美洛西林 + 左奥硝唑      | 抗感染三联（美罗培南降阶梯）         | 已用约 3 周          |
| 舒普深                     | 抗感染                    | 累计约 20 天         |
| 谷胱甘肽 1.2 g + 硫普罗宁 0.1 g | 保肝                     | —                |
| 脂肪乳 + 氨基酸 + 葡萄糖 + 电解质   | PN 全静脉营养（约 650 kcal/d） | 7/2 SEMS 后已停     |
| TPF 肠内营养 60 ml/h 鼻饲     | 肠内营养                   | 7/2 SEMS 后已停，改口服 |



九、关键指标趋势

9.1 CA19-9（肿瘤标志物）

| 日期         | 数值        | 说明                            |
|------------|-----------|-------------------------------|
| 2026-03-30 | 2203 U/mL | 基线（73× 上限，合并梗阻性黄疸）            |
| 2026-05-09 | 255 U/mL  | ↓ 88%（主因 ERCP 支架引流解除梗阻，非化疗效果） |

⚠ 说明：2203→255 的下降是胆道引流后胆汁淤积缓解所致，不能作为 AG 有效的独立证据。化疗后真正疗效基线应以 255（5/9 引流后）为准。7 月后 CA19-9 未复查，MDT 建议尽快复测。

9.2 TBIL（总胆红素）

2026-03-30: 162.3 → 05-09: 53.8（-67%）→ 05-19: 29.9（-82%）→ 07-03: 7.8 ☒ → 07-12: 7.3 ☒（仍正常）

关键：7/12 ALT/GGT 反弹但 TBIL 未升 → 胆道支架未完全堵塞，处于早期干预窗

9.3 化疗骨髓抑制轨迹

| 时点                   | WBC      | NEUT     | HGB    | PLT     |
|----------------------|----------|----------|--------|---------|
| 5/9 化疗前              | 5.06     | —        | 100    | 215     |
| 5/16 C1D5            | 3.42 ↓   | 2.01     | 96     | 216     |
| 5/28 C1D17           | 3.54     | 2.21     | 82 ↓ ↓ | 333     |
| 5/31 C2D6            | 2.63 ↓ ↓ | 1.18 ↓ ↓ | 85     | 321     |
| 6/3 C2D9             | 3.68     | 1.82     | 81     | 225     |
| 7/3 C3D25（SEMS 后 D1） | 5.42 ☒   | 3.79 ☒   | 90 ↑   | 272     |
| 7/12 C3D34           | 待查       | 待查       | 待查     | 111 ↓ ↓ |

9.4 感染监测轨迹（PCT / IL-6）

|      |                              |
|------|------------------------------|
| PCT： | 6/21 -> 2.91（胆管炎爆发）          |
|      | 6/22 -> 1.88（美罗培南 15 h -35%） |
|      | 6/25 -> 0.767（舒普深降阶梯）        |
|      | 7/3 -> 0.135 ☐ 最低点           |
|      | 7/12 -> 0.522 ☐ 反弹 4 倍       |

## 十、MDT 讨论要点

### ☒ 讨论问题 1（最紧迫）：胆道塑料支架处置

**背景：** 4/10 置入胆道塑料支架已 3 个月零 5 天；7/12 生化+感染四项证据链提示"支架相关胆汁淤积/亚急性胆管炎再激活"（PCT +286%、ALT +192%、GGT 5.24×、PLT 消耗 -59%），TBIL 仍正常表明处于早期干预窗。

#### MDT 请讨论：

1. 是否择期（1-2 周内）行 ERCP 更换为**金属自膨胀胆道支架（SEMS）**？
2. 还是先行影像（腹部超声 / MRCP）确认支架状态后再决策？
3. 若更换支架，抗生素是否需先升级或行血培养 + 胆汁培养定向？
4. 换支架窗口与化疗恢复的时序如何安排？

### ☒ 讨论问题 2：化疗恢复与调整

**背景：** AG 一线 C3 完成，6/13 CT 显示有效；因 6/21 胆管炎中断至今 3 周多。

#### MDT 请讨论：

1. C4 何时启动？（等胆道处理后 vs 处理同期启动）
2. 是否需减量（5/31 曾出现 II 度粒减）？
3. 是否维持 14 天周期不变？

### ☒ 讨论问题 3：临床试验入组方向

**匹配靶点：** KRAS G12D + Claudin 18.2 3+ 60%

#### 候选试验（招募中）：

1. **NCT07296341**：HRS-4642（恒瑞 KRAS G12D 抑制剂）+ Adebrelimab + AG，II 期一线 mPDAC（协和已列，307 待查）
2. **NCT07621718**：Zoldonrasib（RMC-9805）+ 化疗 vs 安慰剂 + 化疗，III 期一线 KRAS G12D（中国分中心待查）
3. **NCT07522073**：INCB161734 + 化疗，III 期一线 KRAS G12D
4. **NCT07255404**：BNT327（PD-L1/VEGF-A 双抗）+ AG/mFOLFIRINOX，II 期一线（清华长庚为中国中心）
5. **NCT07235202**：MR001 + 二线化疗，II 期（清华长庚）
6. **CT041（科济 CLDN18.2 CAR-T）**：PDAC 队列全球 II 期
7. **HLA 分型待查**  
——若 HLA-C\*08:02，可评估 KRAS G12D TCR-T（Anocca ANOC-003 / 国内在研团队）

#### MDT 请讨论：

1. 当前时机是否合适启动试验筛查？（vs 继续 AG 到耐药后再切换）
2. 优先建议哪条路径（KRAS G12D 抑制剂 vs CLDN18.2 靶向 vs TCR-T）？

3. 是否建议先做 HLA 分型？

☒ 讨论问题 4：抗血小板策略

**背景：** 西洛他唑 50 mg BID（脑卒中二级预防，长期）+ 7/12 PLT 111（-59%）+ 无新发血栓但 D-Dimer 曾峰值 1.091

**MDT 请讨论：**

- 1. 西洛他唑是否需暂停或减量至 PLT 恢复？
- 2. 若需 ERCP 换支架，围术期停药方案？

☒ 讨论问题 5：营养与恶病质

**背景：** ALB 32.8↓ + Cr 46↓（肌肉量减少）+ Na 133.6↓ + 体重较基线 -5 kg

**MDT 请讨论：**

- 1. 是否需恢复短期 PN 支持？
- 2. 白蛋白输注指征？
- 3. 神经科营养/帕金森长期用药是否影响吞咽功能与经口摄入？

十一、既往就诊/咨询医生一览

| 医院          | 科室                | 医生            | 事件                     |
|-------------|-------------------|---------------|------------------------|
| 北京协和医院      | 国际医疗肝胆外科 / 特需基本外科 | —             | 2026-04-01/02 首诊       |
| 北京大学第三医院    | 普外二病房             | 马新晖 / 伍佳龙     | 2026-04-03 入院志签字       |
| 北京大学第三医院    | ERCP              | 张铃福           | 2026-04-10 胆道塑料支架置入 ☒  |
| 北京大学第三医院    | 普外急诊              | 姚炜 / 张耀朋 / 郁炜 | 2026-06-22 三腔营养管       |
| 北京大学第三医院    | 内镜中心              | 姚炜团队          | 2026-07-02 十二指肠 SEMS ☒ |
| 中国医学科学院肿瘤医院 | 内科 2 廊坊院区         | 田爱茹           | AG 化疗主管 ☒              |
| 中国医学科学院肿瘤医院 | 胰胃外科              | 王敏            | 2026-04-07 门诊          |
| 北京朝阳医院      | 肝胆胰腺外科            | 樊华            | 2026-04-24 第二意见        |
| 北京清华长庚医院    | 肝胆肿瘤科             | 苏日嘎           | 2026-05-13 咨询          |
| 北京大学肿瘤医院    | —                 | 周军            | 2026-07-02 二线咨询        |
| 北京中关村医院     | 肿瘤病区              | 主管医生          | 2026-06-23 至今住院 ☒      |

## 十二、患者与家属诉求

1. **争取 OS 最大化**（爸爸 IV 期 mPDAC，AG 一线响应中，希望规划好二线/联合治疗与临床试验窗口）
2. **减少并发症对生活质量的破坏**（本次胆管炎+呕吐是最痛苦的一次）
3. **信息透明**——家属希望与 MDT 充分沟通治疗决策的证据与备选方案
4. **积极但不激进**——不追求任何未经验证的疗法，一切基于循证与临床试验合规路径

---

## 附录：数据版本信息

- 数据截止时间：2026-07-15
- 报告版本：v1.0
- 生成方式：由家属维护的健康记录系统（含飞书多维表格 + 本地 workspace + 每日临床事件日志）汇总
- 联系人：张成毅（子）18600058581 / [robinzhangcy@gmail.com](mailto:robinzhangcy@gmail.com)

⚠ 本报告为家属整理的病史汇报文档，供 MDT 讨论参考。所有诊疗决策以主管医生和 MDT 意见为准。